

УДК: 618.19-006.6.

^{1,2}Ж.Ж. Жолдыбай, ²Ж.К.Жакенова, ²Г.Рузиева, ²Г.Д.Касымбекова, ¹Н.Н.Бекбосынов, ¹Г.С.Ахметова¹Казахский научно-исследовательский институт онкологии и радиологии²Казахский Национальный Медицинский Университет им. С.Д. Асфендиярова

Магнитно-резонансная томография в диагностике рака шейки матки

Аннотация. В работе представлены результаты оценки распространенности РШМ методом МРТ у 85 женщин с верифицированным диагнозом, получивших лечение в КазНИИОнР в 2014 г.

Ключевые слова: диагностика, МРТ, шейка матки, рак.

Актуальность. По данным ВОЗ, ежегодно в мире диагностируют более 500 000 новых случаев рака шейки матки (РШМ) [1]. В Казахстане в 2012 году РШМ по заболеваемости занимал 2 место среди злокачественных новообразований у женщин [2]. Отмечен значительный прирост стандартизованного показателя заболеваемости РШМ в Казахстане за период с 2007 по 2012 годы, который составил 21,2%, в то время как в России темп прироста этого показателя за данный период составил 11,2%. Имеется увеличение стандартизованного показателя смертности в Казахстане среди женщин с РШМ на 13,3% в период с 2007 по 2012 годы [2]. Эффективность лечения РШМ напрямую зависит от своевременной диагностики заболевания и правильной оценки распространенности процесса. Пятилетняя выживаемость при РШМ варьирует от 17% при IV стадии до 92% при I стадии [3]. МРТ широко применяется для диагностики и оценки распространенности РШМ. МРТ дает возможность получать изображения без ограничений в плоскости исследования. Пространственная визуализация при МРТ позволяет наиболее точно решать вопросы топической диагностики, обладает высокой «тканевой» визуализацией. Чувствительность и специфичность МРТ в оценке местной распространенности РШМ составляет 80% и 86% соответственно [4].

Материал и методы. Проведен анализ результатов МРТ органов малого таза 85 женщин в возрасте от 24 до 75 лет с гистологически верифицированным диагнозом РШМ, прошедших обследование в Казахском НИИ онкологии и радиологии с 1 января по 31 декабря 2014 года. Средний возраст пациенток был 49,9 лет (95% ДИ 47,2-52,7). МРТ малого таза проводили с целью уточнения распространенности основного процесса и определения тактики лечения.

Результаты. Чувствительность МРТ в диагностике РШМ составила 97,7%. В норме в режиме T2 слизистая оболочка цервикального канала дает высокий (гиперинтенсивный) сигнал, цервикальная строма, окружающая канал, имеет очень низкий (гипоинтенсивный) сигнал (рисунок 1).

Опухоль шейки матки на МР-срезах имеет среднюю интенсивность сигнала и хорошо визуализируется на фоне гипоинтенсивного сигнала стромы и гиперинтенсивного сигнала цервикального канала в режиме T2 (рисунок 2).

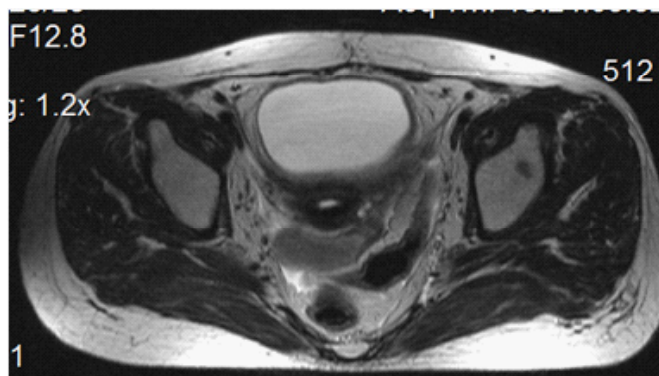


Рисунок 1- МРТ в T2ВИ, аксиальная и сагиттальная проекции. Шейка матки в норме. Цервикальный канал имеет гиперинтенсивный сигнал (стрелка), строма, окружающая цервикальный канал, имеет гипоинтенсивный сигнал

Чаще всего опухоль шейки матки была однородной структуры (72,3%). Неоднородность структуры опухоли составила 27,7%, из них в 2,4% неоднородность структуры была обусловлена распадом. Визуализация опухоли шейки матки зависела от ее размера. Средний максимальный размер опухоли шейки матки в нашем исследовании составил 5,2 см. Из них в 2 (2,4%) случаях I стадии РШМ опухоль не визуализировалась на МРТ-срезах, тогда как по данным патоморфологического исследования инвазия стромы составляла до 1,0 см. Эндофитный тип (85,6%) роста РШМ превалировал над экзофитным (14,4%). При определении распространенности процесса при РШМ было выявлено: опухоль располагалась только в шейке матки в 41,0% случаев, опухоль из шей-

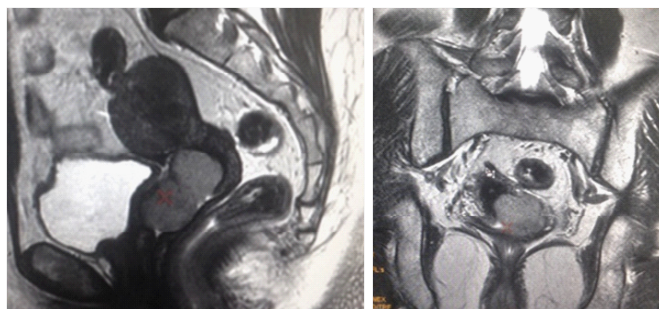


Рисунок 2 - МРТ в T2ВИ, сагиттальная и фронтальная проекции. Рак шейки матки с распространением до 1/3 влагалища. Опухоль шейки матки визуализируется как образование со средней интенсивностью сигнала и хорошо визуализируется на фоне гипоинтенсивного сигнала стромы и гиперинтенсивного сигнала цервикального канала

ки матки распространялась в верхнюю треть влагалища в 38,6% случаев, опухоль распространялась в среднюю треть влагалища в 8,4% случаев, опухоль распространялась в нижнюю треть влагалища в 2,4% случаев, опухоль распространялась на тело матки в 9,6% случаев.

Одним из важных критериев распространенности процесса при раке шейки матки является оценка наличия или отсутствия инвазии параметрия. Инфильтрация параметрия в нашем исследовании установлена в 50,6% случаев. Признаком отсутствия инфильтрации параметрия на МРТ-срезах является сохранение целостности наружного контура стромального кольца шейки матки в виде интактной пластинки с низким сигналом (рисунок 3).

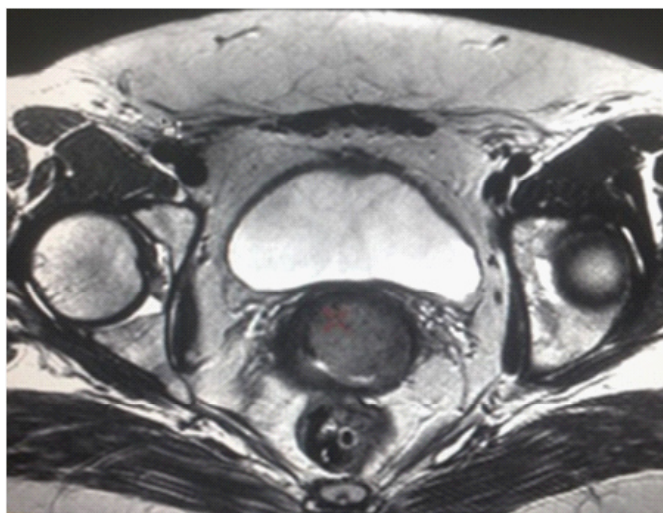


Рисунок 3 - МРТ в Т2ВИ, аксиальная проекция. Рак шейки матки. Отсутствие инвазии в параметральную клетчатку – имеется сохранение целостности наружного контура стромального кольца шейки матки в виде пластинки с низким сигналом вокруг

Признаками инфильтрации параметрия при РШМ на МРТ-срезах являются нарушение целостности стромального кольца шейки матки, появление клиновидных выпячиваний в сторону параметрия, которые выглядят, как участок ткани с пониженным сигналом на фоне гиперинтенсивного сигнала от жира (рисунок 4).

Метастатическое поражение тазовых лимфатических узлов установлено в 54,2% случаев. Подозрение на опухолевую инфильтрацию стенки мочевого пузыря установлено в 2 (2,4%) случаях, переход опухолевой инфильтрации с шейки матки на стенку прямой кишки установлен в 5 (6,0%) случаях.

Сочетание РШМ с миомой матки выявлено в 22,9% случаев. Образования яичников в сочетании с РШМ выявлены в 14,5% случаев.

Вывод. МРТ является методом выбора для оценки распространенности процесса при раке шейки матки.

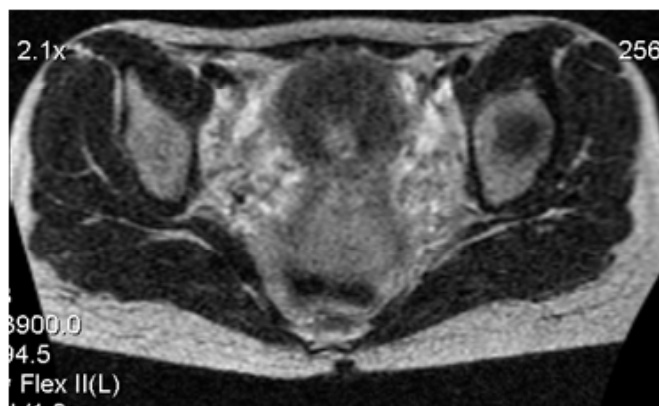


Рисунок 4 - МРТ в Т2ВИ, аксиальная проекция. Рак шейки матки. Отмечается инвазия в параметральную клетчатку с обеих сторон

Список литературы

1. Макаров И.О., Овсянникова Т.В., Шеманаева Т.В. и др. 3D УЗИ в норме и при изменениях шейки матки //Акушерство. Гинекология. Репродукция. – – 2013.-Т.7, №2. – С. 23-26.
2. Давыдов М.И., Аксель Е.М. Статистика злокачественных ново-образований в России и странах СНГ в 2012 году.-РОНЦ.- М., 2014.- 226 с.
3. Sala E., Wakely S., Senior E., Lomas D. MRI of Malignant Neoplasms of the Uterine Corpus and Cervix //AJR. – 2007. – Vol. 188. – P. 1577-1587.
4. Рубцова Н.А., Новикова Е.Г., Сеницын В.Е. Возможности МРТ в предоперационной оценке местной распространенности рака шейки матки. // Акушерство. Гинекология. Репродукция. – 2012.-Т.6, №3. – С. 6-13.

Тұжырым

^{1,2}Ж.Ж. Жолдыбай, ²Ж.К. Жакенова,

²Г. Рузиева, ²Г.Д. Касымбекова,

¹Н.Н. Бекбосынов Н.Н., ¹Г.С. Ахметова

¹Қазақтың онкология және радиология ҒЗИ

²С.Д. Асфендияров атындағы Қазақты

Ұлттық медицина университеті

Жатыр мойны қатерлі ісігін диагностикалаудағы магнитті- резонансты томография

Бұл жұмыста МРТ көмегімен диагнозы анықталған және ҚазО және РҒЗИ емделген 85 әйелдегі жатыр мойны қатерлі ісігінің таралуын бағалау нәтижелері ұсынылады.

Түйінді сөздер: диагностика, МРТ, жатыр мойны, қатерлі ісік.

Summary

^{1,2}Zh.Zh. Zholdybay, ²Zh.K. Zhakenova,

²G. Ruzieva, ²G.D. Kasimbekova,

¹N.N. Bekbosinov, ¹G.S. Ahmetova

¹Kazakh Research Institute of Oncology and Radiology ²Kazakh National Medical University

im.S.D. Asfendiyarova

MRI for diagnoses cervix cancer

The paper presents the results of evaluation cervix cancer by MRI in 83 women, whose take the therapy in Kazakh Research Institute of Oncology and Radiology in 2014 year.

Keywords: diagnostic, MRI, cervix, cancer.